

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ САНИТАРНЫХ ПОСТОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Рубрика: ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИРОВКИ

Автор: Окунева Г.А. Внештатный сотрудник редакции журнала

Статья содержит цели, задачи, программу подготовки личного состава и порядок организации соревнований санитарных постов на муниципальном уровне. Публикация предназначена для специалистов ГОЧС предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образования и имеющих санитарные посты, а также органов управления ГОЧС.

Соревнования санитарных постов (далее – СП) являются одной из эффективных форм обучения и проводятся с целью совершенствования теоретических знаний и закрепление практических навыков, которые в дальнейшем позволяют своевременно оказывать помощь пострадавшим.

Задачами соревнований являются:

- проверка состояния оснащенности и уровня подготовки членов СП, их готовности к действиям по назначению при чрезвычайных ситуациях, авариях и катастрофах;
- совершенствования практических навыков командиров СП по управлению личным составом команд;
- обобщение и обмен опытом;
- выявления недостатков в подготовке СП, разработка мероприятий по их устранению (обучение, тренировки, при необходимости дооснащение СП);
- повышение мотивации членов СП, определение, поощрение и награждение лучших СП

Порядок организации соревнований

Соревнования СП проводятся ежегодно.²⁸ При необходимости допускается вносить дополнения и изменения в программу соревнований. Вносимые дополнения и изменения определяются местными, реально имеющимися условиями и соответствуют программе подготовки, но не упрощают работу СП на этапах соревнований.

Соревнования проводятся в соответствии с планами основных мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год.

Для участия в соревнованиях привлекаются СП объектов экономики, в том числе входящие в другие нештатные формирования и прошедшие подготовку по установленной программе (в состав санитарных постов не включаются лица моложе 18 лет, женщины, имеющие детей до 3 лет, лица с высшим и средним медицинским образованием).

При проведении соревнований очередность работы СП определяет протокол жеребьевки, по которому постам присваиваются порядковые номера.

Личный состав СП допускается к соревнованиям после представления списка личного состава, заверенного подписью руководителя объекта экономики и его печатью. СП, прибывшие не в полном составе и не обеспеченные табельным имуществом, к соревнованиям не допускаются.

Соревнования СП проводятся только на специально оборудованных участках местности либо в спортивном зале с имитацией очагов ядерного и химического поражения. Избранный район на местности должен обеспечивать проведение всех этапов соревнований, иметь сооружения или застройки для имитации очагов. Запрещается проводить соревнования в лесу, парках и других необорудованных местах.

Перед началом соревнований для судей организационным комитетом соревнований (далее – оргкомитетом) организуются методические совещания с показом места (местности) проведения соревнований, а для командиров СП – совещание и рекогносцировка по этапам соревнований с целью изучения маршрута СП. Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности участников соревнований.

Соревнования СП любого масштаба должны проводиться не более чем в два потока, с оценкой действий всех СП одной судейской комиссией.

Оценка знаний и практических навыков личного состава СП на этапах соревнований осуществляется членами судейской комиссией, создаваемой из числа сотрудников медицинских организаций, расположенных на территории муниципального образования (по согласованию), специалистов органов, уполномоченных на решение вопросов ГО и ЧС, создаваемых при органах местного самоуправления, органах исполнительной власти субъектов РФ, сотрудников учебных учреждений, оказывающих образовательные услуги в области медицины, и представителей общественных организаций.

Состав судейской комиссии утверждается оргкомитетом соревнований. Организует работу судейской комиссии и руководит ходом соревнования главный судья, который утверждается на заседании судейской комиссии либо решением

оргкомитета соревнований. Ведением документации соревнований, оборудованием места (района) соревнований занимается оргкомитет.

Ответственность за подготовку и проведение соревнований СП несет начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования.

Финансирование проведения соревнований СП обеспечивают организаторы мероприятия.

Этапы соревнований

Все этапы соревнований СП проходят на выделенных площадках, где созданы условия для выполнения конкретного комплекса практических действий СП, соответствующих определенному разделу программы их подготовки²⁹. Участники соревнований обязаны пройти все этапы, указанные программой соревнований, причем каждому СП создаются равноценные условия работы.

Командиру санитарного поста разрешается поправлять ошибки, сделанные членами СП только в ходе оказания первой помощи условно пострадавшим (далее – пострадавшие), при работе в очагах ядерного и химического поражения.

После завершения работы на каждом этапе членам СП предоставляется несколько минут для отдыха. При работе на этапе соревнования членам СП запрещается задавать вопросы судьям, вступать в пререкания. За командиром СП остается право рассмотреть претензии после завершения работы на последнем этапе и, при необходимости, подать жалобу главному судье соревнований в течение одного часа. Главный судья, судьи этапов рассматривают все заявления командиров санитарных дружин, постов до окончания соревнований. По каждому заявлению принимается решение и объявляется командиру СП. Оценка работы на этапах соревнований проводится судьями в соответствии с судейскими листами. При оценке качества работы санитарных постов на этапах соревнований учитывается время их работы в очагах ядерного и химического поражения.

Первый этап: проверка оснащения санитарного поста и умение пользоваться предметами табельного имущества

Проверяется табельное оснащение СП. Выборочно проверяется укомплектованность одной сумки в каждом санитарном poste. Неисправные предметы оснащения, носилки с порванными полотнищами, лямки без пряжек, порванные либо потерявшие эластичность жгуты считаются как отсутствующие, за что СП засчитываются в соответствии с судейскими листами штрафные очки.

Умение пользоваться предметами табельного имущества (носилками, лялками, противогазом, комплектом индивидуальным медицинским гражданской защиты КИМГЗ, индивидуальным противохимическим пакетом ИПП, перевязочным пакетом, дозиметрическими приборами и т.д.), подручными средствами оказания первой

помощи и транспортировки пострадавших проверяется выборочно, но не менее чем у двух членов СП.

Проверка группового выполнения норматива N 1 – надевание противогаза на себя проводится у всего личного состава СП, и норматива N 2 – надевание противогаза на пораженного, у двух членов СП выборочно, судья отмечает время выполнения нормативов. За неумение пользоваться табельным или учебным оснащением и допущенные ошибки при его использовании судьи начисляют штрафные очки в соответствии с судейским листом.

Второй этап: работа санитарных постов в очаге ядерного поражения, на площадке частичной дезактивации, частичной санитарной обработки

СП в полном составе и с оснащением прибывает к судье очага ядерного поражения. Командир СП докладывает о готовности к работе в очаге.

На этапе проверяется:

- умение по указанным симптомам определять поражающие факторы и оказывать надлежащую помощь пострадавшим;
- умение проводить частичную либо полную санитарную обработку и частичную дезактивацию.

Судья этапа вручает командиру СП задание с описанием обстановки на участке работы. В задании указано: характер разрушения, уровень радиации, направление выноса пострадавших, место их погрузки на транспорт, выделяемые транспортные средства и количество пострадавших, которых следует разыскать, провести их первичную сортировку, оказать необходимую первую помощь, вынести и погрузить на транспортные средства.

Получив задание, командир объясняет его личному составу, ставит перед ним задачи, вводит на участок работы и руководит действиями личного состава. Граница участка очага ядерного поражения четко обозначается красно-белой оградительной лентой. Территория очага соответственно оборудуется. На участке работы СП должно быть не менее 2 и не более 3 пострадавших, с травмами различной степени тяжести, из которых хотя бы один пораженный должен нуждаться в искусственном дыхании (искусственной вентиляции легких) способом "изо рта в рот" или "изо рта в нос" или непрямом массаже сердца.

Если соревнования проводятся на оборудованных участках, то место погрузки пострадавших должно быть на расстоянии 10 – от центра участка работы. Там размещаются транспортные средства: санитарные автомобили, грузовой автомобиль и автобус, приспособленный для перевозки пострадавших и сопровождающих. Погрузка пострадавших в транспорт осуществляется после их выноса с места поражения.

Пострадавшие размещаются в щелях, простейших укрытиях, полуразрушенных убежищах, на вторых этажах зданий, в транспортных средствах, завалах. Вначале погрузке подлежат те раненые, которые нуждаются в эвакуации в первую очередь. Общее количество пострадавших, подлежащих погрузке, определяется программой в зависимости от масштаба соревнований. Нормативное время работы СП в очаге ядерного поражения от момента начала постановки задачи командиром до погрузки или транспортировки составляет 10 минут.

СП, работающие в очаге (с погрузкой пострадавших) больше нормативного времени, получают дополнительно по одному штрафному очку за каждую минуту.

В имитационных билетах указывается только симптоматика (без диагноза). Члены санитарного поста работают в очаге ядерного поражения в ватно-марлевых повязках, респираторах либо противогазах. После завершения работы и погрузки пострадавших участники прибывают на площадку частичной дезактивации и частичной санитарной обработки, где проверяются знания по санитарной обработке пострадавших и побывавших в очаге членов санитарного поста. Частичная дезактивация и частичная санитарная обработка проводится имитационными средствами СП.

За допущенные ошибки при использовании табельного либо учебного имущества, неправильном порядке выполнения алгоритма оказания помощи пострадавшим судьи начисляют штрафные очки в соответствии с судейским листом.

Третий этап: работа СП в очаге химического заражения, площадке частичной дегазации и частичной санитарной обработки

СП в полном составе и с оснащением прибывает к судье этапа химического заражения. Командир докладывает о готовности к работе в очаге. Судья выдает командиру СП задание с описанием обстановки на участке работы.

На этапе проверяется:

- умение по указанным симптомам определять поражающие факторы и оказывать надлежащую помощь пострадавшим;
- умение проводить частичную либо полную санитарную обработку и частичную дегазацию.

В задании указываются размеры очага (ориентиры на местности), какими отравляющими веществами образован очаг химического поражения, общее количество пострадавших, подлежащих розыску, сортировке, оказанию первой помощи, выносу (выводу) к месту погрузки: направление выноса пострадавших, а также установленное время работы СП в очаге.

На участке работы должно быть не менее 2 пострадавших различными отравляющими веществами, с различной степенью поражения в каждой группе.

При проведении соревнований пострадавшие размещаются в зданиях, в простейших укрытиях, на транспорте.

Границы очага химического поражения обозначаются желтыми флажками. На участке работы указателями обозначаются, какими отравляющими веществами образован очаг, а также показывается направление ветра.

СП в очаге химического поражения работает в противогазах, резиновых перчатках и в своей одежде, предусмотренной табелем оснащения, принимая меры к защите открытых частей тела.

Все пострадавшие после оказания первой помощи доставляются к площадке дегазации и санитарной обработки, отмеченной указателем с учетом направления ветра (направление ветра обозначается указателем), после чего СП выстраивается и командир докладывает о завершении работы в очаге.

Нормативное время работы в очаге 10 минут. Работавшие представители СП в очаге больше нормативного времени получают дополнительно по одному штрафному очку за каждую минуту, превышающую нормативное время. Поражение отравляющими веществами имитируются путем описания симптомов в билетах и с указанием диагноза. Частичная дегазация и частичная санитарная обработка проводится членам СП и наличными средствами на указанной площадке, на которой обозначена зараженная и "чистая" части площадки и указано направление ветра.

За допущенные ошибки при использовании табельного либо учебного имущества, неправильном порядке выполнения алгоритма оказания помощи пострадавшим судьи начисляют штрафные очки в соответствии с судейским листом.

Документация соревнований СП

1. Положение о соревнованиях санитарных постов, утвержденное Администрацией муниципального образования. В нем должны содержаться основные указания СП об объеме работы на этапах и основные требования, которые будут предъявлены на данных соревнованиях, исходя из местных условий. Программа доводится до всех участников соревнований за 1 – 2 месяца, в зависимости от объема соревнований.
2. Список судейской комиссии по этапам соревнований с указанием фамилии, имени и отчества, места работы и должности судей.
3. Имитационные билеты и задания с описанием симптоматики поражений пострадавших в очагах ядерного и химического поражения.
4. Протокол и сводная ведомость.
5. Судейские листы по этапам соревнований и рабочим точкам (при необходимости).

Состав и порядок комплектования судейской комиссии

В состав судейской комиссии включаются сотрудники органов здравоохранения, специалисты медицинских учреждений либо преподаватели учебных организаций, оказывающих образовательные услуги по обучению вопросам здравоохранения, а также сотрудники органов, специально уполномоченных на решение вопросов ГОЧС в органах местного самоуправления и представители общественных организаций (при наличии медицинского образования).

Количественный состав судейской комиссии определяется в зависимости от масштаба соревнований, целей и задач, предусмотренных программой соревнований, а также числа участвующих в них СП. Примерный состав судейской комиссии городских (районных) соревнований: главный судья, секретарь соревнований, судья этапа по проверке табельного имущества и умения пользоваться им, судья очага ядерного поражения, судья очага химического поражения.

Члены судейской комиссии оказывают консультационную помощь личному составу СП в период подготовки команд к соревнованиям методом проведения семинарских занятий с разъяснением алгоритмов поведения в очагах поражения, оказания помощи пострадавшим и разбором заданий, указанных в имитационных билетах.

Подведение итогов соревнований

Итоги соревнований подводятся на закрытом заседании судейской комиссии под руководством главного судьи. Призовые места СП в соревнованиях определяются по общему количеству полученных штрафных очков с учетом их времени работы в очагах ядерного и химического поражения.

При одинаковом количестве штрафных очков у нескольких СП первенство присуждается команде, имеющей меньше штрафных очков (суммарно) за работу в очагах поражения, а при равном количестве штрафных очков в очагах поражения предпочтение отдается команде, затратившей на работу в очагах меньшее время. В спорных случаях вопрос решается голосованием присутствующих на заседании старших судей этапов.

При общем построении СП главный судья объявляет результаты соревнований и награждает СП, занявшие призовые места.

Приложение

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА САНИТАРНЫХ ПОСТОВ

Программа соревнований включает три этапа. Участники соревнований обязаны пройти все этапы, указанные в программе.

На первом этапе проводится проверка оснащенности санитарного поста и умение пользоваться предметами табельного имущества.

На этапе проверяется:

- умение пользоваться предметами табельного имущества – носилками, лямками, противогазом, комплектом индивидуальным медицинским гражданской защиты КИМГЗ, перевязочным пакетом и т.д., подручными средствами оказания помощи и транспортировки пострадавших;
- выполнение норматива N 1 – надевание противогаза на себя (групповое);
- выполнение норматива N 2 – надевание противогаза на пораженного. Выполняется двумя членами СП.

Примерные практические задания 1-го этапа:

- наложение колосовидной повязки на плечевой сустав либо наложение повязки "чепец";
- приведение в рабочее положение носилок санитарных, правила транспортировки пострадавшего;
- изготовление из подручных средств и наложение шины для иммобилизации верхних либо нижних конечностей;
- наложение давящей повязки при артериальном кровотечении.

На втором этапе проверяется работа санитарных постов в очаге ядерного поражения, на площадке частичной дезактивации, частичной санитарной обработки.

Члены санитарного поста работают в очаге ядерного поражения в респираторах либо противогазах. После завершения работы и погрузки пострадавших участники прибывают на площадку частичной дезактивации и частичной санитарной обработки, где проверяются знания по санитарной обработке пострадавших и побывавших в очаге ядерного поражения членов санитарного поста. Частичная дезактивация и частичная санитарная обработка проводится имитационными средствами СП.

Нормативное время работы СП в очаге ядерного поражения от момента начала постановки задачи командиром до погрузки или транспортировки составляет 10 минут.

Личный состав СП разыскивают и сортируют пораженных, оказывая необходимую помощь. Затем доставляют их к месту транспортировки, с учетом направления ветра (направление ветра обозначается указателями). Все пораженные доставляются к площадке дегазации и санитарной обработки.

На этапе проверяется:

- умение по указанным симптомам определять поражающие факторы и действовать сообразно установленной тяжести поражения;

- умение выходить из очага поражения с учетом направления ветра;
- умение проводить первичную сортировку пораженных согласно полученных ими травм;
- умение проводить частичную дегазацию и частичную санитарную обработку пораженных и личного состава санитарного поста.

Примерные практические задания 2-го этапа:

- оказать помощь пострадавшему с переломом нижней (верхней) конечности и артериальным кровотечением;
- оказать помощь пострадавшему, находящемуся без сознания (проведение сердечно-легочной реанимации – искусственная вентиляция легких (методом рот-в-рот), непрямой массаж сердца);
- оказание помощи при электротравме;
- провести частичную санитарную обработку и дезактивацию личного состава СП и пораженным.

Правильная погрузка пораженных для транспортировки:

- при погрузке "с ходу" в кузове должен быть человек, которому идущий впереди передает ручки носилок, затем вместе двигают носилки вперед;
- при погрузке пораженного в кузов вдвоем, предварительно поставить носилки на землю, встать по обе их стороны, широко взяться руками за брусья, осторожно поднять носилки и опустить передний их конец на кузов. Один носильщик держит задние ручки носилок, другой влезает в кузов и передвигает носилки вперед;
- при транспортировке пораженных без носилок, вначале в кузов насыпают землю, песок, сверху покрывают мягким настилом – бытовые матрацы.

Правильность выполнения частичной дезактивации и санитарной обработки при выходе из зоны ядерного поражения:

- по команде, не снимая средств защиты, личному составу СП построиться в одну шеренгу на расстоянии не менее друг от друга, лицом навстречу ветру;
- стряхнуть щетками (вениками) пыль с одежды, снаряжения и обуви;
- по команде повернуться налево, обработать впереди стоящего со стороны спины, затем повернуться кругом, поменяться ролями;
- чистой водой обмыть перчатки, протереть влажным тампоном лицевую часть противогаза (респиратора);

- снять перчатки, противогаз (респиратор). Обмыть руки, лицо, шею водой, прополоскать рот, промыть глаза.

На третьем этапе проверяется работа санитарного поста в очаге химического заражения, площадке частичной дегазации и частичной санитарной обработки.

На этапе проверяется:

- умение по указанным симптомам определять отравляющие вещества и оказывать надлежащую помощь пострадавшим;
- умение выходить из очага поражения с учетом направления ветра;
- умение проводить первичную сортировку пораженных согласно полученных ими травм;
- умение проводить частичную либо полную санитарную обработку и частичную дегазацию.

СП в очаге химического поражения работает в противогазах, резиновых перчатках и в форме, предусмотренной табелем оснащения, принимая меры к защите открытых частей тела.

Все пострадавшие после оказания необходимой помощи доставляются к площадке дегазации и санитарной обработки. Нормативное время работы в очаге 10 минут. Поражение отравляющими веществами имитируются путем описания симптомов в билетах.

Нормативное время работы сандружин в очаге не более 15 минут.

Примерные практические задания 3-го этапа:

- оказать первую медицинскую помощь пораженному фосфорорганическими отравляющими веществами (ОВ нервно-паралитического действия: зарин, зоман), либо синильной кислотой (замедленная форма) (ОВ общетоксического действия), либо ипритом (ОВ кожно-нарывного действия), либо отравляющими веществами раздражающего действия (адамсит, си-эс, стерниты) с обязательным введением антидота (условно) с учетом степени тяжести отравления;
- провести частичную санитарную обработку и дегазацию одежды индивидуальным противохимическим пакетом (правильность последовательности проведения обработки и дегазации);
- наложить повязку или давящую повязку на рваную рану (область живота, предплечья, голени) или на обожженные поверхности;

- оказать помощь пострадавшему, находящемуся без сознания (проведение сердечно-легочной реанимации – искусственная вентиляция легких (методом рот-в-рот), непрямой массаж сердца).

Правильность выполнения частичной дегазации и санитарной обработки при выходе из зоны химического заражения:

- обработку личный состав СП проводит по команде командира имеющимися табельными средствами. Сандружинники становятся лицом навстречу ветру на грязной половине.

- по команде "Снаряжение снять" личный состав СП снимает санитарные сумки, носилочные лямки (при наличии) и все кладут позади себя.

- по команде вскрывают пакет ИПП, тампоном, обильно смоченным жидкостью из флакона, протирают открытые участки кожи, а также наружную поверхность шлем – маски одетого противогаза. Другим смоченным тампоном протирают края обмундирования, прилегающие к открытым участкам тела, а также видимые пятна ОВ на нем.

- для обработки одежды личный состав СП распределяется попарно, помогая друг другу.

- использованные тампоны складываются в отведенное место.

- сандружинники снимают сумки, перчатки и складывают в отведенное место.

- по команде делают шаг против ветра, поворачиваются кругом, спиной к ветру, снимают противогазы.

- задержать дыхание и закрыть глаза, поддеть большим пальцем маску противогаза в затылочной части, снять противогаз и бросить его на землю.

- повернуться лицом к ветру, открыть глаза, продолжить дыхание.

Примечания

28. Сроки и даты проведения соревнований определяются на местах и могут различаться в различных муниципальных образованиях.

29. Программа подготовки личного состава санитарных постов содержится в приложении к статье.